TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

AKUT BRÖSTSMÄRTA

HEART score • TnT 0 h och 1 h • Handläggning

Värdera alltid först: AKS, aortadissektion, lungemboli och pneumothorax (utredning, se 03). Algoritmen nedan gäller alla som söker för bröstsmärta där TnT bedöms indicerat. Källa s. 2

01 HEART SCORE

Källa s. 2

	2 POÄNG	1 POÄNG	0 POÄNG
Smärtkaraktär misstanke om hjärtischemi	Hög	Intermediär	Låg
EKG	Signifikanta ST-sänkningar	Ospecifika ST-sänkningar eller obedömbart EKG	Normalt
Ålder	≥65 år	45–65 år	<45 år
Riskfaktorer	≥3 riskfaktorer eller aterosklerotisk sjukdom	1–2 riskfaktorer	Inga kända
Troponin T	>42 ng/L	15–42 ng/L	≤14 ng/L

Riskfaktorer: diabetes, rökning (senaste 90 dagarna), hypertoni, hyperlipidemi, ärftlighet för kranskärlssjukdom, övervikt (BMI >30), tidigare kardiovaskulär sjukdom. **Summa 0–3:** låg risk – **grönt block** nedan. **4–7** medelhög och **>7** hög risk för hjärtkärlhändelser – **orange block**.

⚠ **PM:et otydligt:** både ≥65 år (2 poäng) och 45–65 år (1 poäng) – en 65-åring hamnar i båda grupperna.

02 TNT OCH HANDLÄGGNING

Källa s. 2–3

Om TnT ska analyseras: ordinera alltid seriellt – vid ankomst (0 h) och minst 1 timme senare. Vid sjuksköterskedriven triage tas båda utan läkarordination. Svaret på 0 h-provet finns inte alltid när 1 h-provet tas.

HEART SCORE 0–3			
TnT 0 h <5	→	**AKS ej sannolikt.** Överväg annan diagnos eller utskrivning från akuten.	
TnT 0 h 5–14	→	1 h: ΔTnT <3	→ **AKS ej sannolikt.** Överväg annan diagnos eller utskrivning från akuten.
		1 h: ΔTnT ≥3	→ **Handläggning som vid AKS** om ej annan orsak till TnT-stegringen – gäller även om båda värdena är ≤14. **Kardiologkontakt.**
TnT 0 h >14	→	**Kardiologkontakt** om misstanke om AKS.	
HEART SCORE 4–10			
TnT 0 h ≤14	→	Ta 3 h-prov	→ Överväg **inläggning**, alternativt **poliklinisk stresstest**.
TnT 0 h >14	→	**Handläggning som vid AKS** om ej annan orsak till TnT-stegringen. **Kardiologkontakt.**	

TnT i ng/L. ΔTnT = ändring mellan 0 h- och 1 h-provet.

⚠ **PM:et otydligt:** vid HEART 4–10 och TnT 0 h ≤14 anger flödesschemat inte hur 1 h-provet används eller hur 3 h-provet ska tolkas.

- **TnT kan vara normalt vid hjärtinfarkt** om provet tas kort efter symtomdebut – var frikostig med nytt prov någon timme senare vid hög misstanke om AKS.
- TnT-stegring är oavsett orsak prognostiskt mycket ogynnsamt. Stabilt förhöjt TnT med annan förklaring och liten risk för AKS: fokusera på varför patienten söker.

03 UTREDNING

Källa s. 1–2

Anamnes inkl. smärtdebut · EKG · blodstatus, elstatus inkl. P-kreatinin, CRP, TnT. **D-dimer** vid misstanke om lungemboli. **Blodtryck i båda armarna** vid misstanke om aortadissektion. **Lungröntgen** vid misstanke om sjukdom i lungor eller pleura. **DT thorax** vid stark misstanke om lungemboli eller aortadissektion.

Region Uppsala: ”Akut bröstsmärta, utredning AKM AS”.
DocPlusSTYR-14513 · version 5 · godkänt 2023-04-25.
Via akutkompassen.se/#pm=14513 · hämtat 2026-10-15.
Original-PM (DocPlus)

⚠ = punkt där PM:et självt är otydligt.

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.

TESTDOKUMENT Sammanfattning av Kjell Stefansson – inte av PM:ets författare